

TEMA 3.39 • OBSTETRICIA

Trabajo de Parto Prematuro — Manejo

PERFIL EUNACOM 3.01.2.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Trabajo de Parto Prematuro — Manejo

Definición

- **Amenaza/Síntomas de PP (APP):** Contracciones regulares ( $\geq 6/h$  o  $\geq 1$  cada 10 min) **sin** modificaciones cervicales
- **Trabajo de parto prematuro (TPP):** Contracciones regulares **con** modificaciones cervicales

Screening (asintomática)

- **Cervicometría transvaginal** a las **20–24 semanas** (toda embarazada)
- Corte: **< 25 mm** → cuello corto → riesgo

| TABLA 3.39.1: LONGITUD CERVICAL VS RIESGO DE PARTO EN 7 DÍAS |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| LONGITUD CERVICAL                                            | RIESGO DE PARTO EN 7 DÍAS |
| > 30 mm                                                      | ~1%                       |
| < 15 mm                                                      | ~50%                      |

Medidas preventivas

| TABLA 3.39.2: INDICACIÓN VS TRATAMIENTO                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| INDICACIÓN                                                               | TRATAMIENTO                               |
| < 25 mm en screening, PP previo o incompetencia cervical                 | <b>Progesterona vaginal</b> 16–36 semanas |
| < 25 mm + $\geq 2$ abortos tardíos/PP extremos o cerclaje urgente previo | <b>Cerclaje</b>                           |

Manejo en Urgencia (APP)

- **Cervicometría** (corte en urgencia: **30 mm**)
- Si > 30 mm → observar 1h: cede → alta; empeora → manejo TPP
- Si < 30 mm → manejar como TPP
- Si < **15 mm** → **amniocentesis directa** (descartar infección)

Manejo del TPP según EG

| TABLA 3.39.3: EG VS CONDUCTA |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| EG                           | CONDUCTA                           |
| $\geq 34$ semanas            | Dejar evolucionar (no tocolíticos) |
| < 34 semanas                 | Frenar + maduración pulmonar       |

Si < 34 semanas:

- **1. Corticoides antenatales** (ventana: 24–34 sem)
  - Betametasona 12 mg/día  $\times$  2 días
  - o Dexametasona 6 mg c/12h  $\times$  4 dosis
  - Previenen: EMH, hemorragia periventricular, enterocolitis, mortalidad
- **2. Tocolíticos de 1ª línea** (objetivo: 48h para que actúen corticoides)

- **Nifedipino** ( $\geq 32$  sem — más usado)
- **Indometacina** (24–31 sem)
- **3. Si no responde** → **amniocentesis:**
  - Infección (+) → ATB + interrumpir
  - Infección (–) → tocolíticos de **2ª línea:** atosibán; betamiméticos (fenoterol, ritodrina)
- **4. Sulfato de magnesio** (neuroprotección < 34 sem → previene parálisis cerebral)
- Carga: 4 g EV → mantención 2 g/h hasta el parto
- Indicado cuando: fallan tocolíticos 1ª línea o están contraindicados

Contraindicaciones de Tocolíticos

| TABLA 3.39.4: ABSOLUTA VS RELATIVA (= ABSOLUTA EUNACOM) |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ABSOLUTA                                                | RELATIVA (= ABSOLUTA EUNACOM) |
| Dilatación > 6 cm                                       | Dilatación <b>3–6 cm</b>      |
| Corioamnionitis clínica                                 | <b>RPM</b>                    |
| Malformación incompatible con vida                      | Metrorragia moderada          |
| Óbito fetal                                             | RCIU                          |
| Metrorragia severa                                      | Preeclampsia importante       |
| Patología materna grave                                 | $\geq 34$ semanas             |

| Deterioro grave fetoplacentario |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Trabajo de Parto Prematuro — Manejo: Manejo del TPP según EG | EG | Conducta | |---|---|  $\geq 34$  semanas | Dejar evol... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trabajo de Parto Prematuro — Manejo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Screening (asintomática)
- Medidas preventivas
- Manejo en Urgencia (APP)
- Manejo del TPP según EG
- Si < 34 semanas:
- Contraindicaciones de Tocolíticos

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRABAJO DE PARTO PREMATURO — MANEJO)

## PREGUNTA 1

En relación a Trabajo de Parto Prematuro — Manejo: Manejo del TPP según EG | EG | Conducta | |---|---| |  $\geq 34$  semanas | Dejar evol... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Trabajo de Parto Prematuro — Manejo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Trabajo de Parto Prematuro — Manejo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Trabajo de Parto Prematuro — Manejo requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Trabajo de Parto Prematuro — Manejo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Trabajo de Parto Prematuro — Manejo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

## PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Trabajo de Parto Prematuro — Manejo?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

## PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Trabajo de Parto Prematuro — Manejo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

## RESUMEN: TRABAJO DE PARTO PREMATURO — MANEJO

1. Cervicometría (corte en urgencia: 30 mm) 2. Si  $> 30$  mm  $\rightarrow$  observar 1h: cede  $\rightarrow$  alta; empeora  $\rightarrow$  manejo TPP 3. Si  $< 30$  mm  $\rightarrow$  manejar como TPP 4. Si  $< 15$  mm  $\rightarrow$  amniocentesis directa (descartar infección)